

CARTILHA DE SINAIS VITAIS PARA O APH

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

OBSERVAR AFERIR REGISTRAR REAVALIAR COMUNICAR

Conteúdo

Pressão arterial • frequência cardíaca • frequência respiratória • temperatura corporal • saturação de oxigênio • dor • registro e reavaliação.

Material didático ilustrado

1. INTRODUÇÃO

OBSERVAR **AFERIR** **REGISTRAR** **REAVALIAR** **COMUNICAR**

Os sinais vitais são indicadores fundamentais do funcionamento do corpo humano. No conteúdo-base são apresentados a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal e, frequentemente, a saturação de oxigênio ou a dor.

No APH, esses parâmetros auxiliam a organizar a observação do estado fisiológico do paciente. A avaliação ganha maior significado quando os dados são registrados, comparados e reavaliados ao longo do atendimento.

IDEIA CENTRAL

Não trate um valor como informação isolada: observe o paciente, registre as condições da aferição e acompanhe a evolução.

2. COMO ORGANIZAR A AVALIAÇÃO



Uma sequência simples ajuda o aluno a manter organização durante o treinamento e a simulação:

1. OBSERVAR

Avalie o estado geral e as condições do atendimento.

2. AFERIR

Utilize equipamento e técnica compatíveis com sua capacitação e protocolo.

3. REGISTRAR E REAVALIAR

Anote os dados, o horário e compare os resultados posteriores.

3. PRESSÃO ARTERIAL

PRESSÃO ARTERIAL



A pressão arterial integra o conjunto de sinais vitais destacados no material-base. Sua aferição deve ser feita com equipamento apropriado e técnica compatível com o treinamento recebido.

Antes de registrar, observe as condições da avaliação. Anote o resultado de forma legível, acrescente o horário e outras informações relevantes conforme o protocolo adotado.

PONTO DE REGISTRO

REGISTRO: valor aferido • horário • condições relevantes.

4. FREQUÊNCIA CARDÍACA



A frequência cardíaca é um parâmetro central da avaliação de sinais vitais. No treinamento, o aluno deve reconhecer a importância da contagem e da observação da regularidade percebida, conforme o método utilizado.

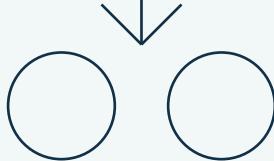
O dado deve ser relacionado ao estado geral do paciente e comparado em reavaliações quando a situação exigir.

PONTO DE REGISTRO

OBSERVAR: frequência • regularidade percebida • horário • evolução.

5. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA



A frequência respiratória faz parte dos parâmetros fundamentais da avaliação. Além da contagem, a observação do padrão respiratório pode fornecer informações importantes no contexto do APH.

Registre a frequência e as características percebidas dentro dos limites de sua capacitação e do protocolo do serviço.

PONTO DE REGISTRO

OBSERVAR: frequência • padrão percebido • esforço aparente • evolução.

6. TEMPERATURA CORPORAL

TEMPERATURA CORPORAL



A temperatura corporal é um dos sinais vitais citados no conteúdo-base. A aferição deve considerar o método e o equipamento disponíveis.

O registro deve permitir comparação posterior e indicar, quando aplicável, o método utilizado.

PONTO DE REGISTRO

REGISTRAR: valor • método/local quando aplicável • horário.

7. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

SpO₂

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

A saturação de oxigênio é frequentemente incluída na avaliação. A leitura obtida deve ser considerada junto ao estado do paciente e às condições da aferição.

Verifique a leitura apresentada pelo equipamento e registre o resultado conforme os procedimentos ensinados no curso.

PONTO DE REGISTRO

ATENÇÃO: equipamento + leitura + observação do paciente + evolução.

8. DOR E AVALIAÇÃO DO PACIENTE



A dor é frequentemente considerada na avaliação. O relato do paciente deve ser valorizado e registrado conforme o instrumento ou protocolo adotado pelo serviço.

A organização do registro permite acompanhar mudanças durante o atendimento e comunicar informações de forma objetiva.

REGISTRO

Localização • intensidade conforme escala/protocolo • características relatadas • evolução.

9. RELAÇÃO COM A ANATOMIA

O material-base também apresenta a anatomia humana como a ciência que estuda a forma, a estrutura e a organização das partes do corpo, abrangendo sistemas como o esquelético, o muscular e o nervoso.

VISÃO INTEGRADA

Células → tecidos → órgãos → sistemas → funcionamento do organismo.

10. REGISTRO, COMPARAÇÃO E REAVALIAÇÃO



A conclusão apresentada no material-base destaca que os parâmetros aferidos podem refletir estabilidade ou risco de deterioração orgânica. Por isso, registrar e comparar resultados é parte importante do acompanhamento.

REGISTRE COM CLAREZA

Parâmetro • resultado • horário • condições relevantes.

COMPARE

Observe tendências de melhora, manutenção ou mudança.

COMUNIQUE

Transmita achados de forma objetiva à equipe responsável.

AVALIAÇÃO TEÓRICA — PARTE 1

1. Os sinais vitais são indicadores fundamentais de:

- a) Funcionamento do corpo humano
- b) Apenas força física
- c) Somente idade
- d) Cor do uniforme

2. Qual parâmetro é citado no material-base?

- a) Pressão arterial
- b) Cor dos olhos
- c) Altura
- d) Profissão

3. Qual conjunto contém parâmetros citados?

- a) Pressão, frequência cardíaca e respiratória
- b) Peso, altura e visão
- c) Cor, idade e peso
- d) Audição e paladar

4. A temperatura corporal é:

- a) Um dos sinais vitais
- b) Dado administrativo
- c) Sem importância
- d) Medida de uniforme

5. A saturação de oxigênio é mencionada como:

- a) Parâmetro frequentemente incluído
- b) Dado irrelevante
- c) Apenas exame documental
- d) Substituto da avaliação

6. A dor pode ser:

- a) Considerada na avaliação
- b) Sempre ignorada
- c) Apenas um dado visual
- d) Nunca registrada

7. Uma sequência organizada inclui:

- a) Observar, aferir, registrar e reavaliar
- b) Apenas medir uma vez
- c) Comunicar sem observar
- d) Registrar sem aferir

AVALIAÇÃO TEÓRICA — PARTE 2

8. O horário deve ser registrado para:

- a) Organizar a evolução dos dados
- b) Evitar reavaliação
- c) Substituir a medida
- d) Eliminar comunicação

9. A reavaliação permite:

- a) Comparar a evolução
- b) Apagar dados
- c) Evitar registro
- d) Ignorar o paciente

10. Um valor isolado deve ser:

- a) Considerado junto ao contexto
- b) Sempre suficiente
- c) Sempre ignorado
- d) Inventado

11. A frequência cardíaca faz parte:

- a) Dos sinais vitais
- b) Do uniforme
- c) Do cadastro
- d) Da anatomia isolada

12. Na avaliação respiratória pode ser relevante observar:

- a) Frequência e padrão percebido
- b) Apenas assinatura
- c) Marca do uniforme
- d) Somente horário

13. Na temperatura, quando aplicável, é útil registrar:

- a) Método utilizado
- b) Cor do equipamento
- c) Nome do prédio
- d) Número do uniforme

14. A leitura de saturação deve ser considerada:

- a) Com o estado do paciente
- b) Sem contexto
- c) Sem conferir equipamento
- d) Apenas no fim do atendimento

AVALIAÇÃO TEÓRICA — PARTE 3

15. A anatomia humana estuda:

- a) Forma, estrutura e organização do corpo
- b) Apenas medicamentos
- c) Apenas doenças
- d) Somente exercícios

16. Qual sistema é citado como exemplo?

- a) Esquelético
- b) Financeiro
- c) Trânsito
- d) Administrativo

17. Os parâmetros podem refletir:

- a) Estabilidade ou risco de deterioração
- b) Apenas preferência
- c) Cor do local
- d) Marca do aparelho

18. A comunicação dos achados deve ser:

- a) Objetiva e organizada
- b) Sem registro
- c) Baseada em suposição
- d) Desnecessária

19. Uma sequência de medidas ajuda a:

- a) Perceber evolução
- b) Eliminar observação
- c) Evitar registro
- d) Substituir o paciente

20. A avaliação deve respeitar:

- a) Capacitação, protocolos e limites de atuação
- b) Preferência pessoal apenas
- c) Nenhuma orientação
- d) Apenas rapidez

AVALIAÇÃO PRÁTICA — 10 ITENS

Instruções: aplique em cenário simulado, observando segurança, organização, técnica compatível com o treinamento e comunicação. A avaliação deve seguir os protocolos adotados pela instituição.

1. Preparação e organização do material. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

2. Observação inicial do paciente simulado. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

3. Aferição da pressão arterial conforme treinamento. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

4. Avaliação da frequência cardíaca. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

5. Avaliação da frequência respiratória. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

6. Aferição da temperatura. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

7. Uso do recurso de avaliação da saturação, quando previsto. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

8. Abordagem e registro da dor conforme protocolo. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

9. Registro organizado dos parâmetros e horários. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

10. Reavaliação e comunicação objetiva dos achados. ☐ Realizou ☐ Parcial ☐ Não realizou

Observação: _____

CORREÇÃO SUGERIDA

1 ponto por item satisfatório, total de 10 pontos. A instituição pode adaptar a escala conforme seu regulamento.

GABARITO DA AVALIAÇÃO TEÓRICA

Questão	Resp.	Questão	Resp.	Questão	Resp.	Questão	Resp.
1	A	6	A	11	A	16	A
2	A	7	A	12	A	17	A
3	A	8	A	13	A	18	A
4	A	9	A	14	A	19	A
5	A	10	A	15	A	20	A

ENCERRAMENTO

A avaliação de sinais vitais reúne informações importantes sobre o estado fisiológico do paciente. Os parâmetros aferidos, especialmente quando registrados e acompanhados ao longo do atendimento, auxiliam a reconhecer estabilidade ou possível mudança do quadro.

MENSAGEM FINAL

Estude • pratique • registre • reavalie • comunique.